29/03/2026

Utdanningsnivå og psykisk helse- en kvantitativ analyse

Mini analyse i R

Mohamoud A. Omar

Innhold

1.0 Innledning 2
2.0 Metode 2
2.1 Data og utvalg 2
2.2 Variabler og operasjonalisering 2
2.3 Analysemetode 3
3.0 Resultater 3
3.1 Deskriptiv statistikk for utdanningsnivå 3
3.2 Korrelasjon mellom utdanningsår og livsstilfredshet 5
3.3 Korrelasjon mellom utdanning og psykisk helseindeks 5
4.0 Diskusjon/konklusjon 6
4.1 Tolkning av funn 6
4.2 Begrensninger 7
4.3 Konklusjon 7
5.0 Litteraturliste 8

1.0 Innledning

Flere studier viser at høyere utdanning henger sammen med bedre psykisk helse, gjennom økt sosioøkonomisk status, bedre tilgang til ressurser og økt mestring (Mirowsky & Ross, 2003; Cutler & Lleras- Muney, 2006). Tidligere forskning har påpekt at psykisk helse bør måles som en sammensetning av symptombaserte indikatorer som angst, depresjon, energiløshet og sosial tilbaketrekning (Kessler et al., 2002). Diener et al. (1985) belyser at livstilfredshet er et for alminnelig mål å fange psykiske symptomer ettersom økonomi, par- og boforhold kan påvirke den subjektive oppfattelsen av psykisk tilstand. I den norske konteksten har SSB nylig dokumentert at subjektiv livskvalitet øker i takt med høyere utdanningsnivå (SSB, 2024). Det er verdt å notere at subjektiv livskvalitet i denne sammenhengen ikke impliserer psykisk helse direkte, men tjener som pekepinn i påbegynnende analyse. På dette grunnlaget vil denne analysen undersøke følgende problemstilling: *Hvordan henger utdanningsnivå sammen med psykisk helse*? Hypotesene å utforske er H1: Analysen av ESS Round-11 dataene i dette studiet vil vise en negativ sammenheng mellom utdanningsnivå (x) og psykisk helse (y). Den sekundære hypotesen (H2): En psykisk helseindeks vil vise en sterkere negativ sammenheng enn et enkelt mål på livstilsfredhet.

2.0 Metode

2.1 Data og utvalg

Den innhentede surveydataen brukt i analysen kommer fra European Social Survey- round 11 og fokuserer på sosiale ulikheter i helse. ESS-data er kvalitetssikret gjennom tilfeldig sannsynlighetsutvalg for å trekke representative konklusjoner av populasjonen som tilhører utvalget. Datainnsamlingen ble gjennomført i 2023 og dekker flere titalls av europeiske nasjoner. I tråd med studiets problemstilling, har dette derimot blitt avgrenset til Norge og har N= 17402 respondenter. Utvalget viser en overvekt av personer med høyere utdanning, noe som muligens skyldes seleksjon inn i surveyen og kan svekke validiteten av funnene. Mer om dette i delen om resultater.

2.2 Variabler og operasjonalisering

Den uavhengige variabelen *utdanningsnivå* operasjonaliseres gjennom variabelen eduyrs, og forstås som antall fullførte år med fulltidsutdanning som en kontinuerlig variabel. Variabelen hadde 69 manglende verdier, et særdeles lavt antall i lys av antall totale respondenter i datasettet. Kessler et.al (2002) konstatering av psykisk helse målt som en indeks av

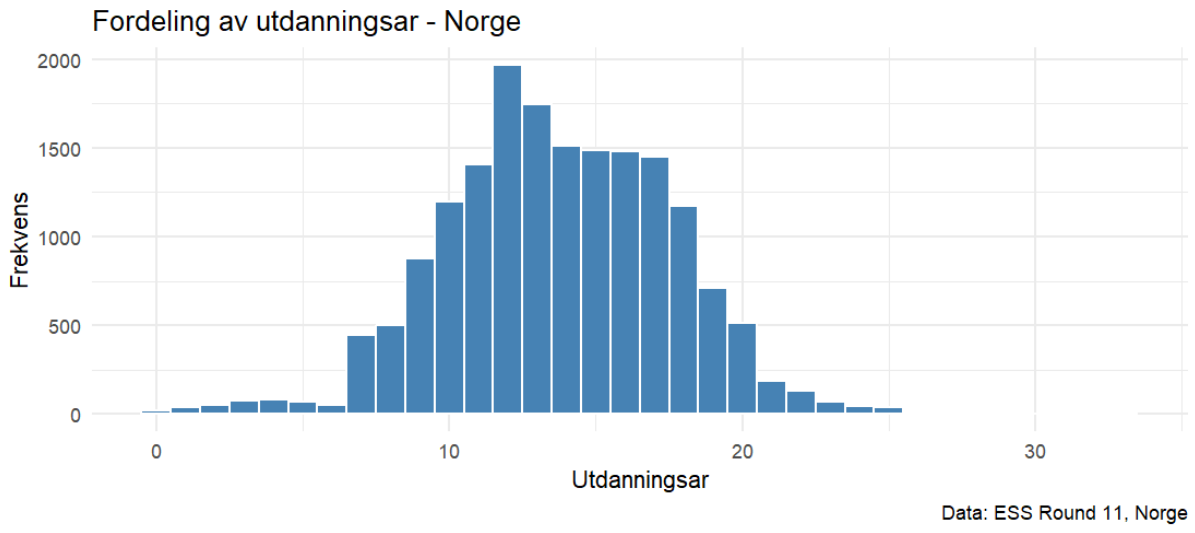
individuelle symptomsbaserte indikatorer, gjøres gjennom fire variabler i denne analysen: fltdpr, fltanx, flteeff og fltlnl. Disse utgjør *psykisk helse*, den avhengige variabelen i studiet. De fire variablene dreier seg om sammensatte følelser av depresjon, angst, følelse av at alt var en anstrengelse og ensomhet den siste uken. Disse er målt 1-4, ettersom 5-9 har manglende verdier. På dette grunnlaget har den sammensatte indeksen blitt omkodet verdier >= 5 til NA. Av N= 17402 respondenter, og dermed avgrenset til 6137 personer inkludert i psykisk helse indeksen. Indeksens evne til å fange psykisk helse er tatt høyde for gjennom Cronbachs alfa (a = 0.67). Dette indikerer forsvarlig nivå, men tolkning av funn bør ta forbehold om dette.

2.3 Analysemetode

For å undersøke sammenhengen mellom utdanningsnivå og psykisk helse brukes Pearsons korrelasjonsanalyse, som måler styrken og retningen på den lineære sammenhengen mellom to *kontinuerlige variabler*. Denne metoden er valgt ettersom eduyrs og mental_health variablene er kontinuerlig der eduyrs er en konkret variant. Psykisk helseindeksen er en sammensatt skala behandlet som kontinuerlig. Den bivariate analysen gjennomføres i to omganger; først mellom eduyrs og livstilfredshet (stflife) og deretter i korrelasjon med den sammensatte psykisk helseindeksen, i forbindelse med H2. Pearsons r er skalert -1/1 der 0 indikerer ingen sammenheng og -1/1 en perfekt negativ eller positiv sammenheng henholdsvis.

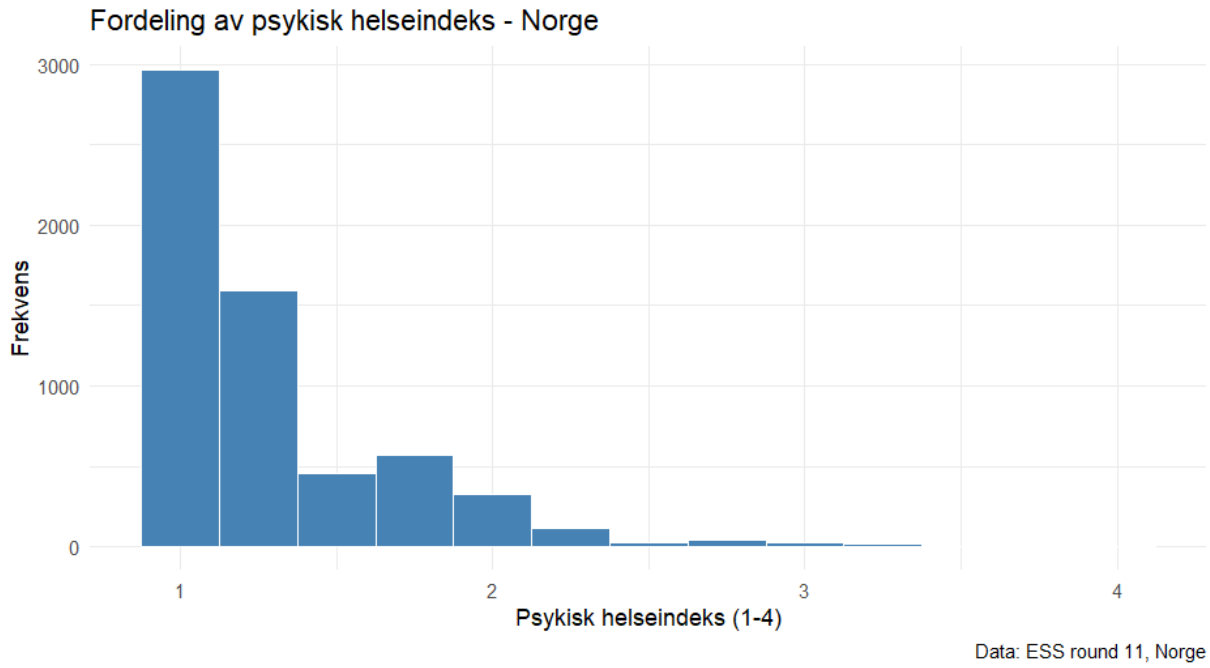
3.0 Resultater

3.1 Deskriptiv statistikk for utdanningsnivå



Figur 1: Fordeling av respondenter på utdanningsår, N= 17333

Figur 1 illustrerer fordelingen respondenter fordelt på fullført fulltidsstudie i utdanningsår, der maksimumverdien på 33 år sannsynligvis reflekterer lengre høyere utdanning. 12 og 13 fullførte studieår viser høyest av frekvens av respondenter. 14 til 17 fullførte studieår viser seg å være stabil fra år til år. Figur 1 støtter oppfatningen om at den norske befolkningen har et gjennomsnittlig høyt utdanningsnivå.

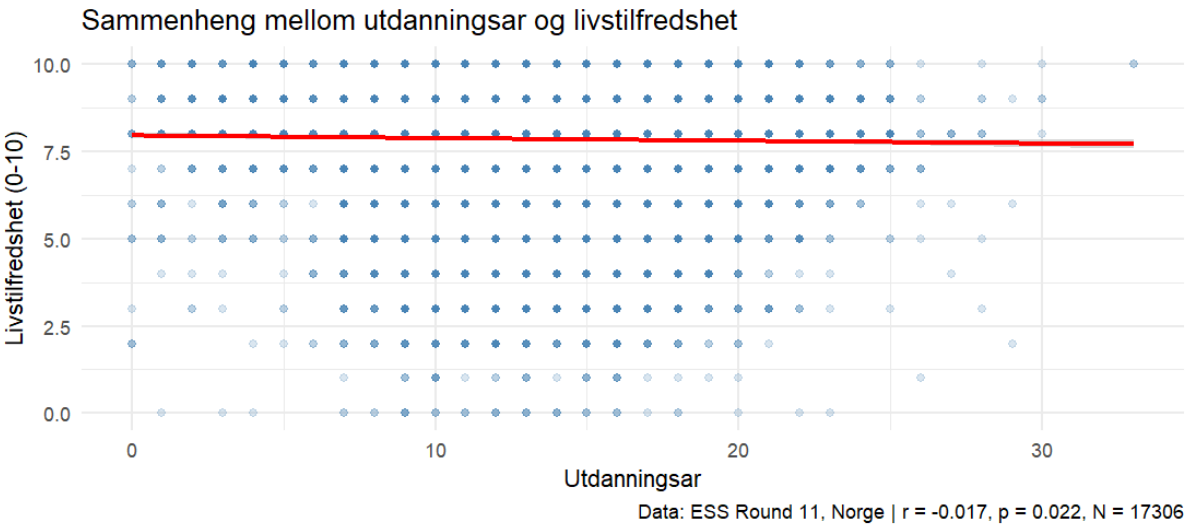


Figur 2: Fordeling av respondenter på psykisk helseindeks, N = 6137

Figur 2 illustrerer fordeling av respondenters score på den psykiske helseindeksen basert på et redusert antall N = 6137, grunnet manglende verdier på noen av de individuelle variablene.

Verdien 1 indikerer lav rapportering av psykiske plager, og de fleste av det gjeldende utvalget befinner seg på denne verdien. Nesten alle respondenter er ≤2, og i overkant av dette er det beskjedent med respondenter. Dette indikerer at majoriteten av det gjeldende utvalget har god generell psykisk helse.

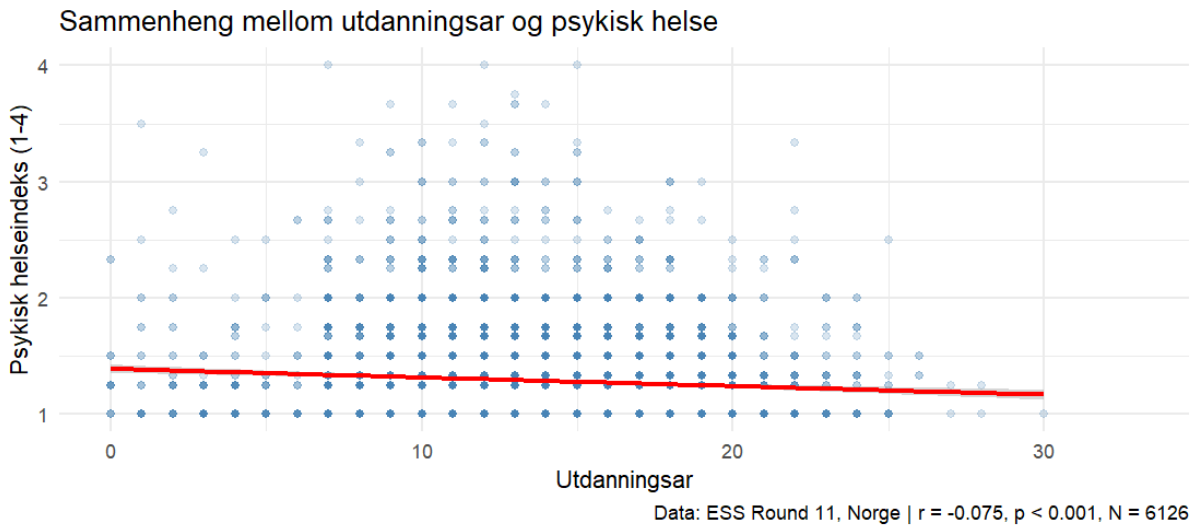
3.2 Korrelasjon mellom utdanningsår og livsstilfredshet



Figur 3: Korrelasjon mellom utdanningsår og livsstilfredshet, r = -0.017, p = 0.022, N = 17306

Figur 3 bygger på N = 17306 observasjoner, og korrelasjonen mellom utdanningsnivå og livsfredshet gitt ved en regresjonslinje. Korrelasjonen viser en meget svak negativ sammenheng (r = -0.017) der respondenters selvoppfattelse av livsfredshet synker i tråd med flere år av fullførte fulltids studier. Korrelasjonen er statistisk signifikant (p = 0.022) innenfor (p <0.05). På grunnlag av den beskjedne korelasjonskoeffisienten derimot, bør dette funnet tolkes med varsomhet.

3.3 Korrelasjon mellom utdanning og psykisk helseindeks



Figur 4: Korrelasjon mellom utdanningsår og psykisk helseindeks, r = -0.075, p < 0.001, N = 6126

Figur 4 viser korrelasjonen mellom utdanningsår og den sammensatte psykiske helseindeksen- depresjon, angst, anstrengelse og ensomhet den siste uken, gitt ved en regresjonslinje. Respondentantallet synker med 11 observasjoner fra figur 2, den deskriptive statistikken av selvrapporterte psykiske plager. Dette er grunnet manglende verdier på utdanningsår i den gjeldende figuren. Korrelasjonen mellom variablene (r = -0.075) innenfor p < 0.001, viser en svak men meningsfull sammenheng der selvrapporterte psykiske plager synker stabilt med flere fullførte studieår.

4.0 Diskusjon/konklusjon

4.1 Tolkning av funn

Tilbakevendende til studiets innledning ble det avklart at denne analysen ville finne en negativ korrelasjon mellom utdanningsnivå og psykisk helse, i tråd med H1. Hypotesen støttes ved figur 3 og 4, men korrelasjonskoeffisientene er for beskjedne (r = -0.017 og -0.075) innenfor p <0.05 og <0.001 til å tillegges praktisk betydning utover denne analysen. Den sekundære hypotesen støttes ettersom korrelasjonskoeffisienten for utdanningsår og psykisk helseindeks viser nesten fire ganger større effekt i sammenligning med livsstilfredshet (Diener et al., 1985; Kessler et al., 2002).

Diener et al. (1985) gjør et konseptuelt skille mellom affektiv og kognitiv selvoppfattelse av individers liv sett i subjektivt lys, der livsstilfredshet utgjør et eksempel på den sistnevnte varianten. Kognitiv selvoppfattelse er en rasjonell vurdering av eget liv. Sett i lys av selvoppfattet psykisk tilstand rapportert i ESS surveydataen, er det mulig at personer vurderer eksterne faktorer som økonomi, par- og boligforhold som mål på deres psykiske helse

gjennom livsstilfredshetsmålet. Dette problematiserer forholdene som ønskes å utforskes, altså den interne psyken heller enn ekstern påvirkning av den. Plausibelt kan dette være forklarende på den betydelig sterkere korrelasjonen som den psykiske helseindeksen illustrerer ved figur 4. Funnene i dette studiet støtter Kessler et. al (2002) sin konstatering om overlegenheten en tilnærming til psykisk helse utgjør når en operasjonaliserer gjennom sammensetninger av individuelle psykiske symptomer. Samsvaret mellom antall fullførte studieår med lavere rapportering av psykiske plager gitt spesielt ved figur 4 støtter også tidligere forskning (Mirowsky & Ross, 2003). Det er verdt å merke frafallet fra N = 17306 i figur 3 til N = 6126 i figur 4. Dette eksemplifiserer muligens respondentenes åpenhet rundt selvrapportering av eksterne faktorer som livsstilfredshet kan representere (Diener et. al, 1985), samt stigmatisering knyttet til rapportering av mål som peker mot den interne psyken, gitt ved helseindeksen.

4.2 Begrensninger

Som nevnt tidligere i analysen, viser helseindeksen intern konsistens (a = 0.67). Dette er under allment akseptabelt nivå på a = 0.7. En medvirkende årsak for dette kan være at variabelen fltanx- angst hadde mangelfulle observasjoner (N = 3364) sammenlignet med de øvrige indeksvariablene (N ≈ 6000+), et element som svekker reliabiliteten av studiet. Figur 1 viser en overvekt av respondenter N = 17333 med antall fullførte fulltids studieår. Spesielt i middel- øvre middelsjikt fra ca. 14 til 17 års fullførte studieår, indikerende fra innføring til fullføring av en bachelorgrad. Dette er sannsynligvis en skjev representering av faktiske forhold. En mulig forklaring kan sees i lys av seleksjonsbias, der personer med høyere utdanning er mer tilbøyelige for deltakelse i akademiske surveys. Eduyrs-variabelen måler bare antall fullførte *fulltids* studieår. Dette er problematisk for å generalisere funn ettersom videreutdanninger og deltidsstudier er etterspurte tilbud både i volum og bredde i Norge, særlig i sosialsektoren. Korrelasjonen mellom utdanningsår og psykisk helse tar ikke høyde for kontrollvariabler som kjønn, alder og inntekt. Inkludering av slike variabler hadde tenkelig påvirket funn, redusert konfudering samt gitt et mer presist bilde av de utspillende forholdene mellom utdanning og psykisk helse.

4.3 Konklusjon

Tilbakevendende til analysens problemstilling, skulle den søke å besvare hvordan utdanningsnivå korrelerer med psykisk helse gjennom to teoretisk anvendte hypoteser. En svak negativ sammenheng ble funnet i forbindelse med H1. Men denne korrelasjonen var

nokså beskjeden til å trekke praktiske betydninger utover utvalget i datasettet. Operasjonalisering av psykisk helse som en indeks av individuelle psykiske symptomer fremfor et enkeltmål, viser seg å være en overlegen tilnærming til å fange begrepet analytisk, i tråd med H2. For å styrke funnenes generaliserbarhet utover utvalg, vil kontrollvariabler være nødvendig i videre forskning, muligvis i form av multivariat analyse. Funnene indikerer at utdanningsnivå er en relevant, om enn beskjeden, faktor i folkehelsefeltet knyttet til psykisk helse. Dette er noe som taler til kompleksiteten av psykisk helse som et målbart fenomen som alene ikke kan forklares av utdanningsnivå.

5.0 Litteraturliste

David M. Cutler and Adriana Lleras-Muney, "Education and Health: Evaluating Theories and Evidence," NBER Working Paper 12352 (2006), https://doi.org/10.3386/w12352.

Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The Satisfaction With Life Scale. J Pers Assess. 1985 Feb;49(1):71-5. doi: 10.1207/s15327752jpa4901_13. PMID: 16367493.

European Social Survey European Research Infrastructure (ESS ERIC) (2025) ESS round 11 - 2023. Social inequalities in health, Gender in contemporary Europe. Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research. https://doi.org/10.21338/ess11-2023

Kessler RC, Andrews G, Colpe LJ, Hiripi E, Mroczek DK, Normand SL, Walters EE, Zaslavsky AM. Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress. Psychol Med. 2002 Aug;32(6):959-76. doi: 10.1017/s0033291702006074. PMID: 12214795.

Mirowsky, J., & Ross, C. E. (2003). *Education, social status, and health.* Aldine de Gruyter.

Statistisk sentralbyrå. (2024). *Sosial ulikhet i livskvalitet* (Rapporter 2024/22). Statistisk sentralbyrå.